

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 002/2026 - Perícia Oficial

Regulamenta os critérios para o Exame Médico nos concursos públicos para provimento de cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal, assim como para a posse no(s) cargo(s), e dá outras providências.

A PERITA-GERAL DA PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 11.236, de 27 de março de 2020, especialmente o art. 2º, parágrafo único, bem como em observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

CONSIDERANDO que o art. 7º da Medida Provisória nº 546, de 1º de abril de 2026, alterou o art. 13 da Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, acrescentando o inciso VI, o qual estabelece que o concurso público para ingresso no Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal compreenderá as fases de exame médico, investigação social, curso de formação profissional e avaliação psicológica, todas de caráter eliminatório;

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios objetivos, uniformes e técnicos para a realização do exame médico nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal, bem como para a verificação das condições de saúde física e mental exigidas para a posse e o exercício das atribuições inerentes aos cargos;

CONSIDERANDO que as atividades desempenhadas pelos servidores da Perícia Oficial de Natureza Criminal demandam aptidão compatível com o exercício de funções de elevada complexidade técnica, exposição a agentes biológicos, químicos e situações de risco, além da atuação em locais de crime e demais ambientes insalubres ou potencialmente traumáticos;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar maior segurança jurídica, transparência, isonomia e eficiência aos certames públicos e aos atos de investidura nos cargos da Perícia Oficial de Natureza Criminal do Estado do Maranhão;

CONSIDERANDO, por fim, a importância de resguardar o interesse público, a continuidade e a qualidade dos serviços periciais prestados à sociedade maranhense

R E S O L V E

Art. 1º. Estabelecer os critérios para o exame médico nos concursos públicos para provimento de cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal e para a posse nos cargos.

**CAPÍTULO: I
Do Exame Médico**

Art. 2º. O exame médico será composto de avaliação médica, realizada por junta médica, de exames laboratoriais e de exames complementares.

Parágrafo Único. A avaliação médica objetiva aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as tarefas típicas inerentes aos cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal.

Art. 3º. Os candidatos convocados para exame médico deverão comparecer aos locais previamente indicados, conforme os editais específicos, para avaliação médica, munidos dos exames laboratoriais e dos exames complementares.

**Seção: I
Da Avaliação Médica**

Art. 4º. A avaliação médica será realizada por junta médica, a qual deverá consignar, objetivamente, os dados observados na respectiva ficha médica, constante do anexo a esta Resolução.

§1º. A critério da junta médica, poderá ser solicitado ao candidato a realização de outros exames laboratoriais e complementares, que deverão ser apresentados no prazo de até 10 (dez) dias e às suas expensas.

§2º. Se na análise do exame clínico, dos exames laboratoriais e complementares for evidenciada alguma alteração clínica, a junta médica deverá determinar se é:

- I- Compatível ou não com o cargo pretendido;
 - II- Potencializada com as atividades a serem desenvolvidas;
 - III- determinante de frequentes ausências;
 - IV- Capaz de gerar atos inseguros que venham a colocar em risco a segurança do candidato ou de outras pessoas;
 - V- Potencialmente incapacitante a curto prazo.
- §3º.** Evidenciadas quaisquer das alterações descritas no parágrafo 2º, o candidato será considerado inapto.

**Seção: II
Dos Exames Laboratoriais**

Art. 5º. Para a avaliação médica deverão ser apresentados pelo candidato os seguintes exames laboratoriais:

- I- Sangue: hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas, Machado Guerreiro, VDRL, sorologia para hepatite B e C, ABO-Rh;
- II- Urina: EAS;
- III- fezes: parasitológico de fezes;
- IV- Toxicológicos de larga escala de detecção, com janela retrospectiva mínima de 180 dias para as seguintes substâncias:
 - **Grupo Anfetaminas:** Anfetamina, Dietilpropiona (Anfepramona), Femproporex, Mazinho
 - **Grupo Canabinoides:** 11-nor-delta-9-THC Ácido Carboxílico, THC (Delta-9-tetrahidrocanabinol),
 - **Grupo Cocaína:** Benzoilecgonina (cocaína), Cocaína ("merla", "Oxi"), AEME (Crack), Coca etileno (cocaína + álcool), No cocaína.
 - **Grupo Metanfetaminas:** Metanfetamina, MDA, MDMA (Ecstasy), MDEA, MBDB.
 - **Grupo Opiáceos:** Morfina, Codeína, 6-acetilmorfina, 6-acetilcodeína, Dihidrocodeína (Hidrocodona), Heroína.
 - **LSD**
 - **Oxicodona**
 - **PCP** (Fenciclidina)

§1º. Ao se inscrever no certame, o candidato autoriza a coleta de material para realização de outros exames toxicológicos, a qualquer tempo, no interesse da Direção Geral de Perícia.

§2º. O resultado positivo para qualquer das substâncias pesquisadas no exame toxicológico, salvo apresentação de prescrição médica idônea, implicará a eliminação do candidato do concurso.

**Seção III
Dos Exames Complementares**

Art. 6º. No decorrer da avaliação médica deverão ser apresentados pelos candidatos os seguintes exames complementares:

- I- Neurológico: eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, laudo e avaliação clínica neurológica realizada pelo especialista.
- II- Cardiológicos, todos com laudo:
 - a. avaliação clínica cardiológica realizada pelo especialista;
 - b. eletrocardiograma;
 - c. ecocardiograma bidimensional com Doppler;

III- Pulmonar:

a. RX de tórax PA e perfil esquerdo, com laudo;

b. prova de função pulmonar;

IV- Oftalmológicos: avaliação oftalmológica pelo especialista, considerando:

a. acuidade visual sem correção;

b. acuidade visual com correção;

c. tonometria;

d. biomicroscopia;

e. fundoscopia;

f. motricidade ocular;

g. senso cromático.

V- Otorrinolaringológicos:

a. avaliação clínica otorrinolaringológica realizada pelo especialista;

b. audiometria tonal.

VI- Raio X de coluna lombar incidências AP e perfil, com laudo.

VII- Ecografia de abdômen total.

VIII- Exame toxicológico de larga janela de detecção com janela retrospectiva mínima de 180 dias

CAPITULO: II**Dos Resultados do Exame Médico**

Art. 7º. São condições clínicas, sinais ou sintomas que incapacitam o candidato no concurso público, bem como para a posse no cargo:

I- Na área da cabeça e pescoço:

a. tumores malignos na área de cabeça e pescoço;

b. alterações estruturais da glândula tireoide associadas ou não a sinais e sintomas de hipertireoidismo;

c. deformidades congênicas ou cicatrizes deformantes ou aderentes que causem bloqueio funcional na área de cabeça e pescoço.

II- No ouvido e audição:

a. perda auditiva maior que 25 (vinte e cinco) decibéis nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz);

b. perda auditiva maior que 30 (trinta) decibéis isoladamente nas frequências de 500, 1000 e 2000 Hz (hertz);

c. otosclerose;

d. labirintopatia;

e. otite média crônica.

III- olhos e visão:

a. acuidade visual a 6 (seis) metros: avaliação de cada olho separadamente;

b. acuidade visual com correção: serão aceitos, 20/20 em ambos os olhos e até 20/20 em um olho e 20/40 no outro;

c. motilidade ocular extrínseca: as excursões oculares devem ser normais;

d. senso cromático: serão aceitos até 3 (três) interpretações incorretas no teste completo;

e. pressão intraocular: fora dos limites compreendidos entre 10 a 18 mmHg;

f. cirurgia refrativa: será aceita desde que tenha resultado na visão mínima necessária à aprovação;

g. infecções e processos inflamatórios crônicos, ressalvadas as conjuntivites agudas e hordéolo;

h. ulcerações, tumores, exceto o cisto benigno palpebral;

i. opacificações corneanas;

j. sequelas de traumatismos e queimaduras;

k. doenças congênicas e adquiridas, incluindo desvios dos eixos visuais (estrabismo superior a 10 D prismática);

l. ceratocone;

m. lesões retinianas, retinopatia diabética;

n. glaucoma crônico com alterações papilares e/ou campi métricas, mesmo sem redução da acuidade visual;

o. doenças neurológicas ou musculares;

p. discromatopsia completa.

IV- boca, nariz, laringe, faringe, traqueia e esôfago:

a. anormalidades estruturais congênicas ou não;

b. desvio acentuado de septo nasal;

c. mutilações, tumores, atresias e retrações;

d. fistulas congênicas ou adquiridas;

e. infecções crônicas ou recidivantes;

f. deficiências funcionais na mastigação, respiração, fonação e deglutição;

g. fenda palatina;

h. lábio leporino.

V- pele e tecido celular subcutâneo:

a. infecções bacterianas ou micóticas crônicas ou recidivantes;

b. micoses profundas;

c. parasitoses cutâneas extensas;

d. eczemas alérgicos crônicos ou infectados;

e. expressões cutâneas das doenças autoimunes;

f. úlceras, edemas ou cicatrizes deformantes que poderão vir a comprometer a capacidade funcional de qualquer segmento do corpo;

g. hanseníase;

h. psoríase;

i. eritrodermia;

j. púrpura;

k. pênfigo: todas as formas;

l. úlcera de estase, anêmica, microangiopática, arteriosclerótica e neurotrófica;

m. colagenose - lúpus eritematoso sistêmico, dermatomiosite, esclerodermia;

n. paniculite nodular - eritema nodoso;

o. neoplasia maligna

VI- sistema pulmonar:

a. distúrbio da função ventilatória pulmonar de qualquer natureza - asma, enfisema pulmonar, etc;

b. tuberculose ativa pulmonar e em qualquer outro órgão;

c. sarcoidose;

d. pneumoconiose;

e. tumores benignos ou malignos do pulmão ou pleura;

f. pneumotórax;

g. RX de tórax: deverá ser normal, investigando-se a área cardíaca, exceto se insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida e sem comprometimento funcional.

VII- sistema cardiovascular:

a. doença coronariana;

b. miocardiopatias;

c. hipertensão arterial sistêmica, mesmo que em tratamento;

d. hipertensão pulmonar;

e. cardiopatia congênita, ressaltada a CIA, a CIV e a PCA corrigidos cirurgicamente, e a valva aórtica bicúspide, que não promovam repercussão hemodinâmica;

f. valvulopatia adquirida, ressaltado o prolapso de valva mitral com ausência de repercussão funcional;

g. pericardite;

h. arritmia cardíaca complexa;

i. insuficiência venosa periférica (varizes profundas);

j. linfedema;

k. fístula arteriovenosa;

l. angiodisplasia;

m. arteriopatia oclusiva crônica - arteriosclerose obliterante, trombo-angeíte obliterante, arterites;

n. arteriopatia não oclusiva - aneurismas, mesmo após correção cirúrgica;

o. arteriopatia funcional - doença de Raynaud, acrocianose, distrofia simpático-reflexa;

p. síndrome do desfiladeiro torácico.

VIII- abdome e trato intestinal:

a. hérnia da parede abdominal com protusão do saco herniário à inspeção ou palpação;

b. visceromegalias;

c. formas graves de esquistossomose e outras parasitoses (ex: doença de Chagas, leishmaniose visceral, malária, amebíase extra intestinal);

d. história de cirurgia significativa ou ressecção importante (apresentar relatório cirúrgico, descrevendo o que foi realizado no ato operatório);

e. doenças hepáticas e pancreáticas;

f. lesões do trato gastrointestinal ou distúrbios funcionais, desde que significativos;

g. tumores benignos e malignos;

h. doenças inflamatórias intestinais;

i. obesidade mórbida.

IX- aparelho geniturinário:

a. anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias;

b. uropatia obstrutiva - estenose de uretra, litíase urinária recidivante;

c. prostatite crônica;

d. rim policístico;

e. insuficiência renal de qualquer grau;

f. nefrite intersticial;

g. glomerulonefrite;

h. sífilis secundária latente ou terciária;

i. varicocele e/ou hidrocele em fase de indicação cirúrgica;

j. orquite e epididimite crônica;

k. criptorquidia;

l. urina: urinálise/urina tipo I e elementos anormais; cilindrúria, proteinúria (++), hematúria (++), glicosúria, atentando-se para a proteinúria e hematúria de candidatos de sexo feminino em época menstrual(normal);

m. a existência de testículo único na bolsa não é incapacitante desde que a ausência do outro não decorra de anormalidade congênita; a hipospádia balânica não é incapacitante.

X- aparelho osteomioarticular:

a. doença infecciosa óssea e articular (osteomielite);

b. alteração de eixo que comprometa a força e a estabilidade das articulações;

c. alteração óssea que comprometa a força e a estabilidade dos membros superiores e inferiores;

d. escoliose desestruturada e descompensada, apresentando mais de 10° Cobb, com tolerância de até 3°;

e. lordose acentuada, com mais de 48° Ferguson (com radiografia em posição ortostática e descalço);

f. hipercifose que ao estudo radiológico apresente mais de 45° Cobb e com acunhamento de mais de 5° em três corpos vertebrais consecutivos;

g. "genu recurvatum" com mais de 5° além da posição neutra em RX lateral, decúbito dorsal com elevação ao nível do calcâneo de 10cm em situação de relaxamento;

h. "genu varum" que apresente distância bicondilar superior a 7cm, cujas radiografias realizadas em posição ortostática com carga, evidencie 5°, com tolerância de mais ou menos 3°, no sexo masculino, no eixo anatômico;

i. "genu valgum" que apresente distância bimaleolar superior a 7cm, cujas radiografias realizadas em posição ortostática com carga, evidenciem 5° no sexo masculino, no eixo anatômico;

j. discrepância no comprimento dos membros inferiores que apresente ao exame, encurtamento de um dos membros, superior a 10 mm (0,10), constatado através de escanometria dos membros inferiores;

k. espondilólise, espondilolistese, hemivértebra, tumores vertebrais (benignos e malignos);

l. discopatia, laminectomia, passado de cirurgia de hérnia discal, pinçamento discal lombar do espaço intervertebral; presença de material de síntese, exceto quando utilizado para fixação de fraturas, desde que estas estejam consolidadas, sem nenhum déficit funcional do segmento acometido, sem presença de sinais de infecção óssea; artrodese em qualquer articulação;

m. próteses articulares de qualquer espécie;

n. doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas; casos duvidosos deverão ser esclarecidos por parecer especializado;

o. luxação recidivante de qualquer articulação, inclusive ombros; frouxidão ligamentar generalizada ou não; instabilidades em qualquer articulação;

p. fratura viciosamente consolidada, pseudoartrose;

q. doença inflamatória e degenerativa ósteo-articular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas;

r. artropatia gotosa, contraturas musculares crônicas, contratura de dupuytren's) tumor ósseo e muscular;

s. distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho ou lesões por esforço repetitivo, incluindo tendinopatias em membros superiores e inferiores;

t. deformidades congênitas ou adquiridas dos pés (pé calvo, pé plano rígido, hálux-valgo, hálux-varo, hálux-rígidos, seqüela de pé torto congênito, dedos em garra com calosidade ou não, calosidade aqui-leia, dedo extranumerário, coalizões tarsal);

u. ausência parcial ou total, congênita ou traumática de qualquer segmento das extremidades;

v. qualquer diminuição da amplitude do movimento em qualquer articulação dos membros superiores e inferiores, da coluna vertebral ou pelve;

XI- doenças metabólicas e endócrinas:

a. "diabetes mellitus";

b. tumores hipotalâmicos e hipofisários;

c. disfunção hipofisária e tireoideana sintomática;

d. tumores da tireoide, exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida;

e. tumores de suprarenal e suas disfunções congênitas ou adquiridas;

f. hipogonadismo primário ou secundário;

g. distúrbios do metabolismo do cálcio e fósforo, de origem endócrina;

h. erros inatos do metabolismo;

i. desenvolvimento anormal, em desacordo com a idade cronológica;

j. doença metabólica.

XII- sangue e órgãos hematopoiéticos:

a. anemias, exceto as carenciais;

b. doença linfoproliferativa maligna - leucemia, linfoma;

c. doença mieloproliferativa - mieloma múltiplo, leucemia, policitemia vera;

d. hipersplenismo;

e. agranulocitose;

f. distúrbios hereditários da coagulação e da anticoagulação e deficiências da anticoagulação (trombofilias).

XIII- doenças neurológicas:

a. infecção do sistema nervoso central;

b. doença vascular do cérebro e da medula espinhal;

c. síndrome pós-traumatismo crânio-encefálico;

d. distúrbio do desenvolvimento psicomotor;

e. doença degenerativa e hereditária degenerativa, distúrbio dos movimentos;

f. distrofia muscular progressiva;

g. doenças desmielinizantes e esclerose múltipla;

h. epilepsias e convulsões;

i. eletroencefalograma digital com mapeamento: fora dos padrões normais.

XIV- doenças psiquiátricas:

a. transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de substâncias psicoativas;

b. esquizofrenia, transtornos esquizotípicos e delirantes;

c. transtornos do humor;

d. transtornos neuróticos;

e. transtornos de personalidade e de comportamento;

f. transtorno de desenvolvimento intelectual.

XV- doenças reumatológicas:

a. artrite reumatoide;

b. vasculites sistêmicas primárias e secundárias (granulomatose de Wegener, poliangiite microscópica, síndrome de Churg-Strauss, poliartrite nodosa, doença de Kawasaki, arterite de Takayasu), arterite de células gigantes, púrpura de Henoch-Schölein;

c. lúpus eritematoso sistêmico;

d. fibromialgia; e. síndrome de Sjögren;

f. síndrome de Behçet;

g. síndrome de Reiter;

h. espondilite anquilosante.

XVI- tumores e neoplasias:

a. qualquer tumor maligno;

b. tumores benignos dependendo da localização, repercussão funcional e potencial evolutivo.

XVII- Resultado positivo para uso de substâncias entorpecentes que podem causar dependência química ou psíquica, conforme elencadas no inciso "IV" do art. 5º no prazo aproximado de 180 (Cento e oitenta dias).



CAPÍTULO: III

Das Disposições Gerais e Finais

Art. 8º. Os exames laboratoriais e complementares mencionados nesta Resolução deverão ser realizados às expensas do candidato e neles deverão constar o nome do candidato, e o número de um documento de identificação, os quais serão conferidos quando da avaliação médica.

Art. 9º. Em todos os exames laboratoriais e complementares, além da identificação do candidato, deverá constar, obrigatoriamente, a devida identificação do profissional responsável pelo exame, sendo motivo de inautenticidade destes a inobservância ou a omissão das referidas identificações.

Art. 10. Os exames laboratoriais e complementares terão validade de 90 (noventa) dias.

Art. 11. O candidato poderá ser submetido a avaliações médicas complementares, de caráter unicamente eliminatório, durante o Curso de Formação Profissional.

Art. 12. Caso o candidato seja considerado inapto, a junta deverá fundamentar tal inaptidão, nos termos do parágrafo 2º do artigo 4º desta Resolução.

§ 1º. Será eliminado do concurso público o candidato inapto no exame médico ou que não tenha se apresentado nas datas e horários estabelecidos.

§ 2º. Será assegurado ao candidato conhecer as razões que determinaram o seu resultado como inapto, bem como a possibilidade de interpor recurso no prazo previsto no Edital do concurso.

Art. 13. O exame médico, de caráter unicamente eliminatório, é uma das fases do concurso público para provimento de cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal

Art. 14. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento da presente Resolução

Art. 15. O exame médico poderá ser acompanhado por um médico da junta médica oficial.

Art. 16. As dúvidas, as controvérsias e os casos não previstos nesta Resolução serão decididos pela Direção Geral de Perícia, ouvida a Junta Médica Oficial e a Comissão do Concurso.

Art. 17. Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.
EM SÃO 07 DE MAIO DE 2026

ANNE KELLY BASTOS VEIGA
Perita Geral

ANEXO FICHA MÉDICA

I - IDENTIFICAÇÃO

- a) NOME _____
- b) INSCRIÇÃO/CARGO _____
- c) IDADE _____
- d) SEXO _____
- e) ESTADO CIVIL _____
- f) IDENTIDADE Nº _____
- g) ÓRGÃO EXPEDIDOR/ UF _____
- h) CPF Nº _____

II - BIOMETRIA

- a) EXAMES LABORATORIAIS
 - ____ HEMOGRAMA COMPLETO
 - ____ CREATININA
 - ____ ABO+RH
 - ____ URINAS (EAS)
 - ____ GLICOSE
 - ____ COLESTEROL
 - ____ BETA-HCG
 - ____ PARASITOLÓGICO
 - ____ URÉIA
 - ____ MACHADO GUERREIRO
 - ____ BILIRRUBINAS
 - ____ TOXICOLÓGICO
 - ____ ÁCIDOÚRICO
 - ____ VDRL
 - ____ TGP/TGO
 - ____ OUTROS

- b) EXAMES COMPLEMENTARES
 - ____ ELETROENCEFALOGRAMA (EEG)
 - ____ OFTALMOLÓGICOS
 - ____ ELETROCARDIOGRAMA (ECG)
 - ____ OTORRINOLARINGOLÓGICOS
 - ____ ECOCARDIOGRAMA
 - ____ AUDIOMETRIA TONAL
 - ____ RX TORAX
 - ____ PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR
 - ____ ECOGRAFIA DE ABDOME TOTAL

III - RELAÇÃO DOS EXAMES LABORATORIAIS/COMPLEMENTARES ALTERADOS _____

IV - ECTOSCOPIA

- a) PESO _____
- b) ALTURA _____
- c) BIOTIPO _____
- d) DEFEITOS FÍSICOS _____
- e) DEFORMAÇÕES _____
- f) ALTERAÇÕES DA FALA E DA MÍMICA _____
- g) ALTERAÇÕES DA MARCHA _____
- h) USO DE PRÓTESES _____
- i) OBSERVAÇÕES _____
- V - ANAMNESE GERAL
- a) SINTOMATOLOGIA _____
- b) ANTECEDENTES PESSOAIS
- 1 - DOENÇAS E CIRURGIAS ANTE _____

2 - HÁBITOS _____

3 - ACIDENTES EM SERVIÇO/DOENÇAS PROFISSIONAIS _____

- c) ANTECEDENTES FAMILIARES _____
- d) OBSERVAÇÕES _____
- VI - EXAME DO APARELHO CARDIO VASCULAR
- a) FREQUENCIA CARDÍACA _____
- b) PRESSÃO ARTERIAL _____
- c) AUSCULTA CARDÍACA _____
- d) VASCULOPATIAS _____
- e) OBSERVAÇÕES _____
- VII - EXAME DO APARELHO RESPIRATÓRIO
- a) FREQUENCIA RESPIRATÓRIA _____
- b) AUSCULTA PULMONAR _____
- c) OBSERVAÇÕES _____
- VIII - EXAME DO SISTEMA NEUROLÓGICO
- a) LAUDO DO EXAME NEUROLÓGICO _____
- b) OBSERVAÇÕES _____

IX - EXAME DO APARELHO DIGESTIVO E ABDÔMEM

- a) DENTES _____
- b) OROFARINGE _____
- c) PALPAÇÃO E PERCUSSÃO DO ABDÔMEM
- 1 - VISCEROMEGALIAS _____
- 2 - HÉRNIAS _____
- 3 - VARICOCELE _____



4 - HIDROCELE _____
 5 - GRAVIDEZ _____
 d) OBESERVAÇÕES _____
 X - EXAME DO APARELHO OSTEOMUSCULAR _____
 a) DESVIODACOLUNA VERTEBRAL _____
 b) ARTROPATIAS _____
 c) _____
 d) OBSERVAÇÕES _____
 XI - DIAGNÓSTICO DO EXAME CLÍNICO _____
 MÉDICO _____ CRM _____
 MÉDICO _____ CRM _____
 LOCAL _____ DATA _____
 XII - PARECER FINAL DOS EXAMES CLÍNICOS / LABORATORIAIS / COMPLEMENTARES
 a) O CANDIDATO ESTÁ _____ APTO _____ INAPTO
 b) JUSTIFICATIVA DA INAPTDÃO (conforme parágrafo 2º do artigo 4º desta IN) _____
 MÉDICO _____ CRM _____
 MÉDICO _____ CRM _____
 MÉDICO _____ CRM _____

RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº003/2026 - PERÍCIA OFICIAL

Regulamenta a avaliação psicológica nos concursos públicos para provimento de cargos integrantes do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal do Estado do Maranhão e dá outras providências.

A PERITA-GERAL DA PERÍCIA OFICIAL DE NATUREZA CRIMINAL DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 11.236, de 27 de março de 2020, especialmente o art. 2º, parágrafo único, bem como em observância aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

CONSIDERANDO que o art. 7º da Medida Provisória nº 546, de 1º de abril de 2026, alterou o art. 13 da Lei nº 9.664, de 17 de julho de 2012, acrescentando o inciso VI, o qual estabelece que o concurso público para ingresso no Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal compreenderá dentre outras etapas, a avaliação psicológica, de caráter eliminatório

CONSIDERANDO a necessidade de disciplinar, de forma uniforme e tecnicamente fundamentada, os critérios e procedimentos aplicáveis à avaliação psicológica nos concursos públicos destinados ao provimento dos cargos integrantes do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal, em razão das peculiaridades, complexidade e elevado grau de responsabilidade inerentes às atividades periciais oficiais.

CONSIDERANDO que o exercício das funções desempenhadas pelos servidores da Perícia Oficial de Natureza Criminal exige adequado equilíbrio emocional, controle comportamental, capacidade de tomada de decisão sob pressão, atenção concentrada, raciocínio lógico, estabilidade psíquica e demais características compatíveis com o desempenho seguro, ético e eficiente das atribuições do cargo

CONSIDERANDO a necessidade de aferição da compatibilidade psicológica do candidato com as atribuições dos cargos públicos vinculados à atividade pericial oficial, resguardando-se o interesse público, a eficiência administrativa, a segurança institucional e a adequada prestação do serviço público

CONSIDERANDO, o disposto na Resolução CFP nº 31, de 15 de dezembro de 2022, na Resolução CFP nº 10, de 21 de julho de 2005, e na Resolução CFP nº 008, de 30 de abril de 2025, todas do Conselho Federal de Psicologia, bem como as normas técnicas e éticas aplicáveis à realização da avaliação psicológica em concursos públicos.

RESOLVE

Art. 1º. Regulamentar a avaliação psicológica nos concursos públicos para provimento de cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal

Parágrafo único. Para efeitos desta Resolução considera-se avaliação psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com o perfil profissiográfico exigido para o cargo pretendido.

Art. 2º. A avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, é uma das fases dos concursos públicos para provimento de cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal.

Art. 3º. A avaliação psicológica será realizada com base nos perfis profissiográficos de cargos do Subgrupo Atividades de Perícia Oficial de Natureza Criminal

Parágrafo único. O perfil profissiográfico tem por objetivo reunir e fornecer informações sobre os vários fatores considerados determinantes ao exercício do cargo, tais como: tarefas, requisitos, restrições e necessidades do cargo.

Art. 4º. A avaliação psicológica poderá compreender a aplicação coletiva e/ou individual de instrumentos para aferir requisitos do cargo, ou seja, características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas, definidos em consonância com o perfil profissiográfico estabelecido para cada cargo.

Art. 5º. A avaliação psicológica será realizada por banca examinadora constituída por membros regularmente inscritos em Conselho Regional de Psicologia.

Art. 6º. A banca examinadora deverá utilizar testes psicológicos validados em nível nacional e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução CFP N.º 008/2025.

Art. 7º. O resultado da avaliação psicológica será obtido por meio da análise conjunta dos instrumentos psicológicos utilizados, os quais deverão ser relacionados ao perfil profissiográfico do cargo pretendido

Art. 8º. O candidato será considerado recomendado ou não recomendado na avaliação psicológica.

§1º Será considerado recomendado o candidato que apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e habilidades específicas de acordo com o perfil exigido para o exercício do cargo pretendido.

§2º Será considerado não recomendado o candidato que não apresentar características de personalidade, capacidade intelectual e/ou habilidades específicas de acordo com o perfil exigido para o exercício do cargo pretendido.

§3º A não recomendação na avaliação psicológica não significará, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que o candidato não atendeu aos requisitos exigidos para o exercício do cargo pretendido

Art. 9º. Será eliminado do concurso público o candidato não recomendado na avaliação psicológica ou que não tenha sido avaliado em razão do não comparecimento nas datas e horários estabelecidos em edital específico.

Art. 10. A publicação do resultado da avaliação psicológica listará apenas os candidatos recomendados, em obediência ao que preceitua o artigo 6º da Resolução nº 008/2025, do Conselho Federal de Psicologia.